Manifestaciones ORL durante la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

B Barry
S Matheron
P Géhanno

Resumen. – La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se caracteriza por la infección de los linfocitos CD4⁺ y de los monocitos-macrófagos. El déficit inmunitario celular resultante favorece las afecciones malignas (sarcoma de Kaposi, linfomas), infecciones debidas a gérmenes oportunistas e infecciones recidivantes por gérmenes banales. El virus mismo es responsable de manifestaciones clínicas debido a su neurotropismo y a la invasión de los tejidos linfoides.

En el transcurso de los diferentes estadios evolutivos de la enfermedad, se observan numerosas manifestaciones clínicas en la zona ORL que pueden ser una forma de descubrir la enfermedad.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Generalidades

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA

Al principio de los años 1980, la aparición de infecciones oportunistas relacionadas con un déficit inmunitario de causa desconocida en la población homosexual en Estados Unidos hizo sospechar rápidamente la transmisión sexual de un agente viral [9]. En 1982, se observaron manifestaciones clínicas similares en toxicómanos por vía intravenosa y en pacientes transfundidos, sugiriendo una contaminación por vía sanguínea. El virus responsable fue identificado en Francia, luego en Estados Unidos en 1983. Desde 1986, la prueba de detección serológica, *enzyme-linked inmunosorbent assay* (Elisa), de alta sensibilidad, combinado con la inmunotransferencia, de alta especificidad, permite la detección de casi la totalidad de los pacientes infectados.

El virus responsable de la enfermedad, el VIH-1, es un retrovirus de la familia de los lentivirus, que poseen un tropismo particular para los linfocitos T auxiliares (CD4⁺) y los monocitos-macrófagos. Otro retrovirus de la misma familia, VIH-2, fue aislado en 1986 en África occidental, donde se ha difundido ampliamente cuyo carácter sería menos patógeno y sus períodos de latencia más prolongados. La replicación viral causa la muerte celular y, de esta forma, provoca una disminución del volumen de los linfocitos CD4⁺.

La evolución clínica de la enfermedad se caracteriza por la existencia de un período de latencia con síntomas escasos o inexistentes; posteriormente, por el déficit inmunitario originado por la infección viral, la presencia de infecciones múltiples y de neoplasias, que definen el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida). La evolución clínica de la enfermedad está directamente relacionada con la tasa de linfocitos CD4⁺. La clasificación actual de los estadios evolutivos de la enfermedad propuesta por los *Centers for Diseases Control* (CDC) tiene en cuenta la presencia de manifestaciones clínicas y el grado de los linfocitos CD4⁺ *(cuadro I)*. En la clasificación americana, el estadio 3 biológico (grado de CD4⁺ <200/ml) identifica el sida, sin importar el estadio clínico. Este estado biológico no se toma en cuenta en la definición francesa, que sólo incluye, para la definición del sida, los criterios clínicos del grupo C [33].

Sin embargo, el grado de linfocitos CD4⁺ es un indicador inexacto de la progresión de la enfermedad. Actualmente, el cálculo de la carga viral, que cuantifica el grado de ácido ribonucleico (ARN) viral plasmático, es el mejor criterio predictivo de la evolución hacia el sida [33].

EPIDEMIOLOGÍA

La epidemia de sida es un problema mundial, cuya amplitud es aún difícil de evaluar; principalmente, en razón del largo período de incubación de la enfermedad, que puede alcanzar más de 10 años. En 1993 el número de personas infectadas por el virus en el mundo se estimaba en 13 millones. El grado de mortalidad a los 5 años de los pacientes en estadio de sida se avecina al 100 %.

Los estudios de prevalencia muestran que la infección es más frecuente en la población heterosexual en África que en Estados Unidos y en Europa. En Francia, desde el inicio de la epidemia hasta el 31 de diciembre de 1995 se habían registrado 39 755 casos de sida [42]. El número total de fallecimientos se estima entre 29 000 y 32 000. La edad media en el momento del diagnóstico del sida oscila entre 30 y 39 años. Las regiones más afectadas son Ile de France, las Antillas y la Guayana, con aproximadamente un caso de sida por cada 600 habitantes desde el inicio de la epidemia. Los grupos de población más afectados son los homobisexuales masculinos (38 % de nuevos casos declarados), los toxicómanos por vía intravenosa (26 %) y los heterosexuales (18 %). Desde 1993, la epidemia parece alcanzar una fase de meseta con una estabilización del número de nuevos casos declarados por semestre. Esta estabilización se ha señalado desde 1993 en los grupos homobisexuales masculinos y toxicómanos, aunque se observa paralelamente una progresión en los heterosexuales (+ 11 % entre 1993 y 1994) [42].

Béatrix Barry : *Chef de clinique-assistant.*
Pierre Géhanno : *Professeur agrégé, chef de service.*
Service d'ORL et de chirurgie cervicofaciale.
Sophie Matheron : *Praticien hospitalier, service de maladies infectieuses et tropicales.*
Hôpital Bichat-Claude-Bernard, 46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris cedex 18.

Cuadro I. – Sistema de clasificación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana para los adultos y los adolescentes (revisión 1993, según [43]).

Número de linfocitos CD4+	Categorías clínicas		
	(A) Asintomático, primo-infección o LPG	(B) Sintomático sin criterios (A) o (C)	(C) Sida
≥ 500/µl	A1	B1	C1
200-499/µl	A2	B2	C2
< 200/µl	A3	B3	C3

Definición del sida (OMS/CDC 1987) (+ tres patologías).
Definición del sida (CDC 1993)

• ***Número de linfocitos CD4+***
Debe utilizarse el resultado más bajo pero no necesariamente el último para clasificar el paciente.
La correspondencia entre el valor absoluto y el porcentaje es la siguiente:
— CD4+ ≥ 500/ml: CD4+ ≥ 29%;
— CD4+ 200-499/ml: CD4+ = 14-28 %;
— CD4+ < 200 ml: CD4+ < 14 %

• ***Categorías clínicas***

Categoría A
Uno o más de los criterios de la lista siguiente en el adulto o el adolescente infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en ausencia de los criterios de las categorías B y C:
— infección VIH asintomática;
— linfadenopatía generalizada persistente (LGP);
— primoinfección sintomática.
Categoría B
Manifestaciones clínicas en el adulto o el adolescente infectado por el VIH no pertenecientes a la categoría C y que responden por lo menos a una de las siguientes condiciones:
— se deben al VIH o indican un déficit inmunitario;
— su evolución clínica o su tratamiento se complican con la infección por el VIH.
Las patologías siguientes pertenecen a la categoría B, sin ser limitativa la lista:
— angiomatosis bacilar;
— candidiasis orofaríngea;
— candidiasis vaginal persistente, frecuente o que responde de manera insuficiente a la terapia;
— displasia del cuello del útero (moderada o grave), carcinoma in situ;
— síndrome constitucional: fiebre (38,5 °C) o diarrea de más de un mes;
— leucoplasia vellosa de la lengua;
— zona recurrente o que invade más de un dermatoma;
— púrpura trombocitopénica idiopática;
— salpingitis, en particular en caso de complicación por abscesos tuboováricos;
— neuropatía periférica.
Esta clasificación es jerárquica, es decir, un sujeto clasificado en la categoría B no puede pasar a la categoría A cuando los signos clínicos han desaparecido.
Categoría C
Esta categoría corresponde a la definición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en el adulto. Cuando un sujeto ha sufrido una de las patologías de esta lista, se clasifica definitivamente en la categoría C:
— candidiasis de los bronquios, traqueal o pulmonar;
— candidiasis del esófago;
— cáncer invasivo del cuello del útero;
— coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar;
— criptococosis extrapulmonar;
— criptosporidiosis intestinal más de un mes;
— infección por el citomegalovirus (que no sea del hígado, del bazo ni de los ganglios linfáticos);
— retinitis por CMV (con pérdida de la visión);
— encefalopatía por VIH;
— infección herpética, úlceras crónicas más de un mes; o bronquial, pulmonar o esofágica;
— histoplasmosis diseminada o extrapulmonar;
— isosporidiasis intestinal crónica (más de un mes);
— sarcoma de Kaposi;
— linfoma de Burkitt;
— linfoma inmunoblástico;
— linfoma cerebral primario;
— infección por *Mycobacterium avium o kansasii,* diseminada o extrapulmonar;
— infección por *Mycobacterium tuberculosis,* cualquiera que sea el sitio pulmonar* o extrapulmonar;
— neumonía por *Pneumocystis carinii;*
— neumopatía bacteriana recurrente*;
— leucoencefalopatía multifocal progresiva;
— septicemia a *Salmonella no typhi* recurrente;
— toxoplasmosis cerebral;
— síndrome caquéctico por VIH.

* Nuevas patologías agregadas en 1993; OMS = Organización Mundial de la Salud; CDC = *Centers for Diseases Control.*

Manifestaciones ORL en la fase de inicio de la enfermedad

PRIMOINFECCIÓN

La fase de primoinfección se manifiesta clínicamente en 50 a 70 % de los pacientes; aparece 15 días a 3 meses después de la contaminación y se caracteriza, frecuentemente por un síndrome de infección viral aguda (adenopatías cervicales y axilares diseminadas, fiebre, mialgias, disfagia dolorosa), raramente por una candidiasis y ulceraciones bucales o manifestaciones graves (meningitis o meningoencefalitis). Biológicamente, en cerca del 50 % de los casos se presenta una inversión de la fórmula sanguínea, con un síndrome mononucleósico, una trombocitopenia y una citólisis hepática. La serología es negativa en el momento de la instauración de estos síntomas y sólo se positiviza en las semanas siguientes, a más tardar 6 meses después, mientras que la antigenemia es positiva.

FASE ASINTOMÁTICA O PAUCISINTOMÁTICA

A menudo la fase precoz de la enfermedad es pauci o asintomática, con un grado de linfocitos CD4+ relativamente elevado (≥ 500 células/mm³). La disminución en la cantidad de CD4+, generalmente de 80 a 90 células/mm³/año, se relaciona con la presencia de síntomas inicialmente descritos bajo el término de complejo relacionado con el sida (CRS), que comprenden los signos generales (fiebre, adelgazamiento, astenia y diarrea) y las infecciones, tales como la candidiasis bucal y la hiperplasia vellosa de la lengua. Aproximadamente 5 % de los pacientes no presentan síntomas después de los 10 años (hasta 15 años hasta la fecha), son llamados «asintomáticos a largo plazo».

■ *Candidiasis orofaríngeas*

Son particularmente frecuentes y recidivantes durante la infección por VIH. Las lesiones pueden presentar diferentes aspectos clínicos conocidos de la candidiasis bucal: formas seudomembranosas (muguet), eritematosas (o atróficas), hiperplásicas o queilitis angular. Las localizaciones esofágicas asociadas deben estudiarse, aunque forman parte de las infecciones oportunistas indicadoras de sida. El tratamiento de las lesiones bucofaríngeas es local. Un tratamiento general por vía oral (ketoconazol, fluconazol o itraconazol) se justifica en las formas resistentes o asociadas a las localizaciones esofágicas.

■ *Leucoplasia vellosa* *(FT fig. 1)*

Se trata de una lesión hiperqueratósica poco frecuente de la mucosa bucal que se encuentra únicamente en los pacientes infectados por el VIH. Se manifiesta en la mayoría de casos por una placa leucoplásica hipertrófica de aspecto «velloso» en el borde libre de la lengua. Las otras localizaciones mucosas (piso de la boca, paladar) son raras. Las lesiones son indoloras y en ocasiones se acompañan de una candidiasis bucal. La responsabilidad del virus de Epstein-Barr ha sido señalada debido al descubrimiento de partículas virales dentro de las lesiones. Por regla general, no es necesario su tratamiento.

■ *Síndrome de linfadenopatía persistente generalizada (LPG)*

Corresponde a una manifestación de la infección por el VIH que se define por la presencia de adenopatías mayores de 1 cm persistentes más de 3 meses, en por lo menos dos zonas ganglionares extrainguinales no contiguas. Estas adenopatías son de tamaño pequeño, indoloras, múltiples, bilaterales y simétricas; a menudo se sitúan en zonas ganglionares axilares, inguinales y cervicales posteriores. Constituyen el foco de una infiltración linfocítica benigna por los linfocitos CD8

y son frecuentes en los pacientes del grupo HLA-DR5 del complejo principal de histocompatibilidad [25]. La hipertrofia del tejido linfoide del anillo de Waldeyer, que se manifiesta por una hipertrofia de las amígdalas linguales y palatinas *(FT fig. 2)* y de las vegetaciones adenoideas, es una de las manifestaciones de la LPG [28]. Las otitis serosas son particularmente frecuentes [13], debido a la obstrucción de las trompas de Eustaquio por una hipertrofia adenoidea. En ocasiones, la sordera resultante justifica una adenoidectomía y la implantación de drenajes transtimpánicos. La frecuencia con la que una otitis serosa se observa en la población infectada por el VIH justifica la práctica de una serología en el análisis etiológico de una otitis serosa del adulto. Una biopsia del cavum es necesaria en caso de alguna duda, con el fin de eliminar una localización rinofaríngea de un linfoma.

■ *Hiperplasia linfoide quística (HLQ) de las glándulas salivales* *(FT fig. 3)*

Antes de la epidemia del SIDA, la infiltración linfoide benigna de las glándulas salivales era una patología poco frecuente. Se encontraba en el caso de un síndrome de Sjögren o se manifestaba por una formación quística localizada, raramente multifocal, designada bajo el término de cistoadenolinfoma. Desde la publicación de Ryan et al en 1985 [44], la hipertrofia por infiltración linfoepitelial benigna de las glándulas salivales principales y sobre todo de la parótida, ha sido frecuentemente observada durante la infección por el VIH. Esta HLQ se manifiesta por la presencia de quistes epiteliales incrustados en un tejido linfoide, formado por folículos hiperplásicos idénticos a los observados en los ganglios en el estadio inicial del síndrome de LPG [10]. Las lesiones pueden observarse en todos los estadios de la infección por el VIH, aunque son particularmente frecuentes en el niño. La etiopatogenia de las lesiones todavía no es clara; por otra parte, estas últimas no forman parte de la clasificación de la evolución de la enfermedad. Algunos autores consideran que se trata de una manifestación del síndrome de LPG al nivel del tejido linfoide anexo al parénquima parotídeo [24], mientras que otros autores mantienen la hipótesis de una manifestación autoinmune.

La lesión de las glándulas parótidas es mucho más frecuente que la de las glándulas submaxilares y sublinguales. Con frecuencia, las lesiones son múltiples, bilaterales y los quistes pueden ser voluminosos, alcanzando hasta 10 cm de diámetro [54]. Los síntomas asociados son diversos e inconstantes: se han señalado dolores, atribuidos a la compresión de los conductos excretores [54], al igual que xerostomía, xeroftalmia y artralgias [25, 46, 55]. El diagnóstico de HLQ se sospecha ante la asociación de una serología VIH positiva, imágenes intraparotídeas quísticas por escáner y una biopsia por punción desprovista de signos de malignidad [51, 58]. Si existe una hipertrofia difusa o lesiones sólidas en el escáner, la biopsia por punción negativa no basta para confirmar el diagnóstico. En este caso, la práctica de una biopsia quirúrgica sería necesaria con el fin de eliminar un tumor maligno cuya frecuencia, para los tumores sólidos, se estima en 40 %, mientras que sólo alcanza el 1 % para las masas quísticas [23].

Puesto que se trata de una patología benigna, el tratamiento de la HLQ sólo se recomienda con un objetivo estético en las formas nodulares quísticas. En algunos casos, se observa una regresión con un corto tratamiento con corticoides en dosis altas, o sobre todo, con un tratamiento antirretroviral [46, 48, 54]. En las formas quísticas, las punciones iterativas de los quistes sólo tienen un efecto transitorio. La radioterapia en baja dosis (10 a 20 grays) puede indicarse en los pacientes en estadio de sida [19], pero las recidivas son frecuentes después de estas dosis de irradiación [4]. Una cirugía por motivos estéticos puede aconsejarse; no obstante, una parotidectomía superficial o, sobre todo, una enucleación simple, comportan el riesgo de recidiva [2, 54].

Manifestaciones ORL observadas durante la evolución del sida

El sida se caracteriza por la presencia de infecciones oportunistas y de patología maligna, presentada en la clasificación del CDC *(cuadro I).*

MANIFESTACIONES TUMORALES

■ *Sarcoma de Kaposi* *(FT figs. 6 a 10)*

El sarcoma de Kaposi es un tumor maligno debido a una proliferación de células endoteliales y de fibroblastos. Se trataba de un tumor raro antes de la epidemia de la infección por el VIH, esencialmente observada en los hombres mayores, con una diseminación rara a los ganglios o a las vísceras. Esta enfermedad respondía bien a un tratamiento con radioterapia o a una monoquimioterapia, con una supervivencia media de 8 a 13 años [22, 27].

El sarcoma de Kaposi observado en los pacientes inmunodeprimidos es más agresivo que la forma llamada «clásica», con una lesión diseminada mucosa, ganglionar o visceral en aproximadamente un tercio de los pacientes [29]. La supervivencia media después del diagnóstico es de menos de 2 años, con menos del 10 % de los pacientes vivos después de 5 años [37].

Se trata de la primera manifestación de la enfermedad en cerca del 20 % de los pacientes [42]. Estudios epidemiológicos han revelado una frecuencia particular de esta patología en los pacientes que han contraído la enfermedad por vía sexual; de esta forma, se ha sugerido rápidamente que el sarcoma de Kaposi pudiera estar relacionado con otro agente transmisible además del VIH. Un virus parecido al herpes, llamado HHV8 *(human herpes virus 8)* fue identificado en 1994 en Estados Unidos como agente potencial de la enfermedad de Kaposi; también se ha encontrado en las lesiones de pacientes originarios de numerosos países del mundo [45].

Durante la infección por el VIH, el sarcoma de Kaposi se manifiesta clínicamente por la instauración de lesiones pigmentadas maculares, papulares o nodulares, raramente ulceradas, indoloras, situadas en la piel, las mucosas y, a veces, las vísceras. La lesión cutaneomucosa cervicofacial es frecuente. Las lesiones son, frecuentemente, de tamaño pequeño (inferior a 3 cm), múltiples y asintomáticas en ausencia de sobreinfecciones o de herida. No desaparecen a la vitropresión; su coloración es variable, roja, azulada o violácea y casi negra sobre las pieles oscuras.

Las localizaciones mucosas del sarcoma de Kaposi pueden aparecer antes de las localizaciones cutáneas. Preferentemente se sitúan sobre el paladar duro y las encías, pero pueden observarse en cualquier punto de la mucosa bucal, orofaríngea y también laríngea, rinofaríngea y sinusal. Las formas profundas submucosas pueden estar recubiertas por una mucosa normal. Las lesiones pueden ser sintomáticas, bien por su localización (disfonía o disnea en las localizaciones endolaríngeas), bien por su tamaño (disfagia) o la presencia de sobreinfecciones o de hemorragias. Las formas ganglionares de sarcoma de Kaposi son más raras; sólo se ha señalado un caso de sarcoma de Kaposi de localización mastoidea [32].

Por regla general, el diagnóstico es clínicamente evidente en los pacientes en el estadio de sida, pero las biopsias resultan necesarias para afirmar el diagnóstico ante una lesión inicial. No obstante, deben ser prudentes, en particular en las formas laríngeas, con el fin de evitar una hemorragia, en especial porque la existencia de alteraciones de la coagulación (por trombopatía) es frecuente en este estadio de la enfermedad.

El tratamiento sólo se recomienda en las formas mucosas sintomáticas o en las formas cutáneas diseminadas o de extensión rápida o que suponen un problema estético, y se

basa en la radioterapia externa (15 grays), la quimioterapia o el interferón alfa. La exéresis quirúrgica o por medio del láser sólo se considera cuando el tamaño o la localización del tumor la impone.

Linfomas

Los linfomas malignos no hodgkinianos (LMNH), esencialmente de tipo B, son frecuentes en los pacientes infectados por el VIH. Se observan en 5 a 10 % de los pacientes [39] y son la primera manifestación del sida en cerca del 5 % de los pacientes [42]. El riesgo de presencia de un LMNH se multiplica por 60 a 100 en la población VIH+ con respecto a la población general [5]. Los linfomas asociados al VIH se caracterizan por su localización extraganglionar, la frecuencia de linfomas cerebrales primarios, su alto grado de malignidad, y el tipo B de la proliferación tumoral (cerca del 90 % de los casos) [39]. Responden menos bien a la quimioterapia que los linfomas observados en la población seronegativa, en razón de la agresividad de la proliferación tumoral y del déficit inmunitario subyacente [31]. Actualmente su frecuencia parece crecer en razón del incremento de la supervivencia de los pacientes, gracias a los tratamientos antirretrovirales [31]. Su fisiopatogenia implica mecanismos múltiples: activación y desregulación del sistema inmunitario por el VIH, papel de algunos virus, como el virus de Epstein-Barr, que se detecta por *polymerase chain reaction* (PCR) en el 66 % de los LMNH observados durante el sida [39].

Los LMNH extraganglionares, en el sida, no parecen tener una zona de predilección. Por otra parte, se han observado tumores de las glándulas salivales, de la región periorbitaria, de las fosas nasales, del cavum y de la laringe [31, 38, 59]. Las lesiones de la cavidad bucal son relativamente frecuentes, puesto que constituyen aproximadamente un 5 % de los LMNH extraganglionares observados durante el sida [59]. La lesión se presenta como una masa de crecimiento rápido, que puede ser sésil, ulcerada, o recubierta de una mucosa normal. El paladar duro y las encías son las localizaciones tumorales más frecuentes [31]. Regularmente se trata de un tumor aislado, excepcionalmente multifocal [14], que puede llegar a evocar un sarcoma de Kaposi [7].

El diagnóstico es histológico y a menudo pone de manifiesto un linfoma de células grandes, un linfoma inmunoblástico o un linfoma de Burkitt.

El tratamiento se basa en la radioterapia externa, en particular sobre las formas localizadas, o en la poliquimioterapia. Sin embargo, esta última se tolera muy mal debido al agravamiento del déficit inmunitario; los fallecimientos por complicaciones infecciosas en el transcurso del tratamiento son frecuentes.

Aunque son menos frecuentes, los linfomas hodgkinianos también se presentan durante el sida. Se caracterizan por localizaciones viscerales frecuentes y una evolución clínica a menudo desfavorable. Casi siempre el virus de Epstein-Barr se aisla en las células de Sternberg.

Carcinomas epidermoides

Actualmente el aumento de la frecuencia de carcinomas epidermoides en los pacientes infectados por el VIH con respecto a la población general sigue siendo muy controvertido. En una serie de 375 pacientes homosexuales seropositivos, Silverman et al mostraron seis casos de carcinomas epidermoides de la lengua y uno del piso [50]. Algunos casos esporádicos han sido señalados [1, 12] pero no se han observado carcinomas epidermoides orofaríngeos en las grandes series publicadas [6, 34]. En un estudio efectuado en Francia en 1995 en cerca de 45 servicios de ORL y de cirugía maxilofacial [3], sólo se observaron 21 casos desde el principio de la epidemia. Cabe anotar la fuerte proporción de pacientes jóvenes y sin ningún o pocos factores de riesgo alcoholotabáquicos. Es posible que la inmunodepresión asociada a la infección por el VIH aumente el riesgo de presencia de carcinomas epidermoides.

INFECCIONES OPORTUNISTAS

Las infecciones debidas a los gérmenes oportunistas son frecuentes en los pacientes en el estadio de sida. Frecuentemente se trata de infecciones diseminadas durante las cuales una patología ORL sólo raramente es el modo de diagnóstico. Pueden ser responsables de ulceraciones bucales, de tumefacciones cervicales y de manifestaciones parotídeas, mastoideas y sinusales.

Ulceraciones bucales

Las ulceraciones bucales debidas al citomegalovirus son más raras que las afecciones esofágicas; su aspecto clínico no es específico [15, 26]. Ulceraciones bucales debidas a *Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans* y *Geotrichum candidum*, han sido observadas en pacientes en el estadio de sida [21]. También se han observado otras raras manifestaciones bucales de infecciones bacterianas. Un caso de ulceración del paladar debida a una micobacteria atípica *(Mycobacterium avium intracelular)* fue señalado en un paciente en el estadio de sida [56]. *Mycobacterium tuberculosis* también se ha aislado episódicamente en pacientes que presentan ulceraciones bucales [21].

Adenopatía(s) unilateral(es) y de gran tamaño (> 3 cm de diámetro)

Su presencia puede indicar una patología maligna u oportunista [49] sobre todo si se acompañan de un síndrome febril. Estas adenopatías son siempre patológicas en los pacientes en el estadio de sida.

Las principales infecciones oportunistas que pueden dar origen de una tumefacción cervical son las infecciones por micobacterias típicas o atípicas. La tuberculosis es una enfermedad frecuente en los pacientes infectados por el VIH: en Francia representa el 6 % de los modos de inicio del sida [42]. Las tuberculosis ganglionares se acompañan frecuentemente con una lesión pulmonar o visceral. El diagnóstico de una tuberculosis ganglionar aislada puede hacerse por el aislamiento por punción ganglionar del bacilo acidoalcoholresistente. En ocasiones, una adenectomía puede ser necesaria para el diagnóstico y también se recomienda en la evolución, en caso de falta de respuesta al tratamiento.

Las infecciones debidas a micobacterias atípicas son diseminadas en este terreno y, en este caso, las adenopatías acompañan una lesión sistémica. El diagnóstico se realiza por hemocultivo o biopsia tisular con cultivo.

Otras infecciones oportunistas parasitarias y fúngicas (toxoplasmosis, infección por *Pneumocystis carinii*, criptococosis, histoplasmosis, etc.) pueden ser responsables de tumefacciones cervicales, aunque muy a menudo lo son en el caso de una afección diseminada.

Patología parotídea

La lesión parotídea por el citomegalovirus se manifiesta en cuatro casos descritos en la literatura médica por una hipertrofia nodular indolora de la parótida [40, 57]. El quinto caso observado se presentó como un dolor de la región parotídea, sin modificación del examen clínico. En todos los casos, el diagnóstico se ha efectuado por biopsia o por citopunción, poniendo en evidencia las inclusiones virales intranucleares. El tratamiento se basa en la administración intravenosa de ganciclovir o de foscarnet. Sólo dos casos de parotiditis vira-

les por adenovirus han sido señalados en pacientes infectados por el VIH [17]. Se trataba de pacientes en el estadio de sida, que presentaban una sintomatología de parotiditis aguda unilateral no febril resistente al tratamiento antibiótico. El diagnóstico se estableció por cultivo viral de una biopsia. La regresión clínica fue espontánea en los dos casos, con un episodio de recidiva bilateral en un paciente.

Mastoiditis

Se han observado algunas mastoiditis en la población adulta infectada por el VIH. Las infecciones debidas a los gérmenes oportunistas *(Aspergillus, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis carinii, Treponema pallidum)* pueden ser la causa.

Sinusitis

Raramente son producidas por los patógenos oportunistas (en particular aspergilares, candidiásicas y criptocócicas). La infección por citomegalovirus y por micobacterias atípicas también puede observarse.

Manifestaciones ORL observadas en todos los estadios de la infección por el VIH

INFECCIONES POR GÉRMENES BANALES

Las infecciones debidas a gérmenes banales son frecuentes, sobre todo cuando la inmunodepresión es importante. Responden bien al tratamiento médico antibiótico en general, pero sobre todo se caracterizan por su naturaleza recidivante. Las otitis y las sinusitis reincidentes se observan especialmente en el niño.

Infecciones nasosinusales

Las sinusitis son frecuentes durante la infección por el VIH. Tienen múltiples presentaciones clínicas: sinusitis aguda, sinusitis crónica, sobreinfecciones de una sinusitis crónica. A veces, son causa de complicaciones meníngeas. Pueden originar molestias en los pacientes y necesitan tratamientos antibióticos repetitivos. La patología sinusal se presenta con una frecuencia que varía entre 30 y 70 % de los pacientes según los estudios [53]. A veces está asociada con episodios de infección pulmonar recidivantes, sin que una relación de causa se haya establecido claramente. El estudio de una fiebre inexplicada encuentra una imagen radiológica de sinusitis en 10 a 20 % de los casos [60]. Numerosos gérmenes se aíslan: *Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*. El estudio bacteriológico de las sinusitis en estos pacientes es muy útil, si se tienen en cuenta los múltiples gérmenes que pueden ser la causa y la frecuencia de resistencia de los gérmenes a los antibióticos en esta población. La respuesta al tratamiento antibiótico es habitual, pero las recidivas son frecuentes, en particular durante las sinusitis por bacilo piociánico, para las cuales, un tratamiento antibiótico prolongado es conveniente.

Las sinusitis crónicas son más frecuentes que las sinusitis agudas [60]. Los senos implicados con mayor frecuencia son los senos maxilares y etmoidales. La frecuencia y la gravedad de la patología sinusal parece correlacionarse con la linfopenia $CD4^+$ [41, 60]. Algunos autores [8] han demostrado una relación entre el nivel de IgE y la gravedad de la sinusitis, sugiriendo un origen alérgico debido a una disfunción inmunitaria en la patogenia de la enfermedad sinusal.

Más raramente se han observado sinusitis debidas a patógenos oportunistas y las localizaciones sinusales de sarcoma de Kaposi o de linfoma. Estas causas inhabituales de sinusitis justifican la práctica de una exploración quirúrgica, con muestra bacteriológica e histológica en caso de evolución desfavorable bajo tratamiento antibiótico.

La cirugía de drenaje de los senos por vía endonasal, en los pacientes que presentan episodios de sobreinfecciones iterativos de una sinusitis crónica, tiene una eficacia inconstante en la prevención de los episodios infecciosos, pero parece aportar una mejoría en la calidad de vida de los pacientes [52].

Patología otológica

Las otitis externas no se observan con frecuencia en esta población. Su manifestación clínica es clásica; los gérmenes responsables son *Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus*, o más raramente, micosis (aspergilosis). En el caso de inmunosupresión, la presencia de una otitis externa maligna es muy probable [35]. Sólo dos casos de otitis externas malignas aspergilares en pacientes infectados por el VIH se han señalado en la literatura [41]. Las localizaciones tumorales de un sarcoma de Kaposi o de un linfoma en el oído externo se observan excepcionalmente [35, 59].

Las otitis medias agudas son especialmente frecuentes en los niños seropositivos [11]. A menudo se acompañan de sinusitis recidivantes. Por regla general, el tratamiento antibiótico es eficaz y los gérmenes responsables no difieren de los encontrados en la población general, pero las recidivas son frecuentes.

Gingivostomatitis

La gingivostomatitis es una afección debida a los gérmenes de la placa dentaria, particularmente evolutiva durante el sida [47]. Se manifiesta por una gingivitis que puede volverse necrotizante y ulcerada; en algunos casos, puede ser extensa y responsable de necrosis ósea, pudiendo indicar la presencia de un noma. El tratamiento se basa en cuidados locales, asociando enjuagues de boca y cuidados dentales. En las formas necrotizantes, se deben asociar antibióticos contra gérmenes anaerobios.

Adenoflemones y celulitis cervicofaciales

Aunque parezca sorprendente, estas infecciones también se observan raramente, a pesar de la inmunodepresión. Se trata esencialmente de infección por *Staphylococcus aureus* (resistente a la meticilina en un cuarto de los casos), como consecuencia de una punción yugular séptica en usuarios de drogas intravenosas [30]. Por lo general, la evolución tras desbridamiento quirúrgico y antibioterapia específica es muy favorable.

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

Se pueden observar afecciones aisladas de los pares craneales (esencialmente del V y del VII) vinculadas al neurotropismo del VIH en los diferentes estadios de la enfermedad. Un electromiograma es útil, ya que muestra la lesión multifocal de la neuropatía. El diagnóstico diferencial consiste esencialmente en descartar un herpes zóster (particularmente frecuente en esta población), una infección por citomegalovirus o una infiltración tumoral.

Las sorderas de percepción son frecuentes, en particular en el estadio de sida. Su modo de instauración es progresivo, aunque se han indicado casos de sordera brusca. Sus causas pueden ser múltiples. Una causa yatrogénica, una lesión meningoencefálica en el curso de una infección oportunista (criptococcosis, toxoplasmosis, leucoencefalitis multifocal progresiva, infección por citomegalovirus) o un linfoma

pueden causar una sordera de percepción. Cuando la sordera es retrococlear, un escáner cerebral puede ser necesario para el diagnóstico etiológico.

Los vértigos se observan raramente. Pueden ser de origen medicamentoso o estar asociados a una neuropatía vinculada al VHI, a una patología infecciosa oportunista o a una lesión tumoral.

ULCERACIONES MUCOSAS DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA *(FT figs. 2, 3, 4)*

En ocasiones se han encontrado ulceraciones mucosas recidivantes en los pacientes infectados por el VIH, en particular en el estadio de sida. Estas lesiones son, a menudo, muy dolorosas y pueden ser causa de disfagia, originando una pérdida de peso que puede ser considerable. Su aspecto clínico es polimorfo: aftas, ulceraciones en «arañazo», lesiones ulcerovegetantes. Frecuentemente se sitúan a nivel del velo del paladar o de la región amigdalina. Su etiología es desconocida. Sin embargo, una biopsia es necesaria para descartar una infección por citomegalovirus, una infección fúngica o en las lesiones voluminosas, una neoplasia (linfoma, carcinoma epidermoide).

El tratamiento de las ulceraciones no específicas se basa en corticoides locales. En las formas con gran disfagia, la talidomida en una dosis de 100 mg durante 5 días, puede revelarse rápidamente eficaz, pero tiene efectos secundarios neurológicos y hematológicos [16].

Conclusión

Durante la infección por el VIH, las patologías encontradas son numerosas y conciernen todos los aspectos de la especialidad ORL y cervicofacial. El tratamiento de los pacientes exige un enfoque particular. Se debe considerar siempre su triple componente: infeccioso, tumoral y relacionado con el virus. En esta óptica, las biopsias para estudio microbiológico e histológico ocupan un lugar especialmente importante ante lesiones de aspecto poco específico.

La colaboración estrecha del médico ORL y de los infectólogos es indispensable para establecer el diagnóstico, informar al paciente y hacerse cargo del tratamiento en el marco de la patología general.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Barry B, Matheron S et Géhanno P. Manifestations ORL observées au cours de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-956-A-10, 1996, 6 p.

Bibliografía

[1] Alhashimi MM, Krasnow ST, Johnston-Early A, Cohen MH. Squamous cell carcinoma of the epiglottis in a homosexual man at risk for AIDS. *JAMA* 1985 ; 253 : 2366

[2] Barry B, Baujat B, Guedon C, Toublanc M, Depondt J, Géhanno P. Hyperplasie lymphoïde kystique au cours de l'infection par le VIH. *Ann Otolaryngol* 1995 ; 112 : 387-392

[3] Barry B, Géhanno P. A french survey of squamous cell carcinoma of the head and neck in human immunodeficiency virus-infected patients. 36th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy [Abstract n° 2329], New Orleans, 15- 18 sept 1996

[4] Beitler JJ, Vikram B, Silver CE, Rubin JS, Bello JA, Mitnick RJ et al. Low-dose radiotherapy for multicystic benign lymphoepithelial lesions of the parotid gland in HIV-positive patients : long term results. *Head Neck* 1995 ; 17 : 31-35

[5] Beral V, Peterman TA, Berkelman RL, Jaffe HW. AIDS-related non-Hodgkin's lymphomas. *Lancet* 1991 ; 1 : 805-809

[6] Biggar RJ, Burnett W, Mikl J, Nasca P. Cancer among New York men at risk for acquired immunodeficiency syndrome. *Int J Cancer* 1989 ; 43 : 979-985

[7] Brahim JS, Katz RW, Roberts MW. Non Hodgkin's lymphoma of the hard palate mucosa and buccal gingiva associated with AIDS. *J Oral Maxillofac Surg* 1988 ; 46 : 328-330

[8] Butkus Small C, Kaufman A, Armenaka M, Rosenstreich DL. Sinusitis and atopy in human immunodeficiency virus infection. *J Infect Dis* 1993 ; 167 : 283-290

[9] Center for Disease Control. Epidemiologic aspects of the current outbreak of Kaposi's sarcoma and opportunistic infections. *N Engl J Med* 1982 ; 306 : 240-252

[10] Chomette G, Auriol M. Hyperplasie lymphoïde kystique des glandes salivaires chez les sujets VIH positifs : étude anatomo-clinique et nosologie. *Rev Fr Lab* 1990 ; 215 : 63-67

[11] Chow JH, Stern JC, Kaul A, Pincus RL, Gromisch DS. Head and neck manifestations of the acquired immunodeficiency syndrome in children. *Ear Nose Throat J* 1990 ; 69 : 416-423

[12] Conant MA, Volberding P, Fletcher V, Lozada FI, Silverman S. Squamous cell carcinoma in sexual partner of Kaposi's sarcoma patient. *Lancet* 1982 ; 1 : 286

[13] Desai SD. Seropositivity, adenoid hypertrophy, and secretory otitis media in adults- a recognized clinical entity. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1992 ; 107 : 755-757

[14] Dodd CL, Greenspan D, Heinic GS, Rabanus JP, Greenspan JS. Multi-focal non-Hodgkin's lymphoma in an AIDS patient. *Br Dent J* 1993 ; 175 : 373-377

[15] Epstein JB, Sherlock CH, Wolber RA. Oral manifestations of cytomegalovirus infections. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1993 ; 75 : 443-451

[16] Gehanno P, Barry B, Depondt J, Guedon C, Poignonec S, Leport C et al. Syndromes hyperalgiques bucco-pharyngés observés au cours du SIDA. *Ann Otolaryngol* 1990 ; 107 : 311-313

[17] Gelfand MS, Cleveland KO, Lancaster D, Corbett CE, Florendo NT. Adenovirus parotidis in patients with AIDS. *Clin Infect Dis* 1994 ; 19 : 1045-1048

[18] Godofsky EW, Zinriech J, Armstrong M, Leslie JM, Weikel CS. Sinusitis in HIV-infected patients : a clinical and radiographic review. *Am J Med* 1992 ; 93 : 163-170

[19] Goldstein J, Rubin J, Silver C, Meritz K, Chao C, Ting J et al. Radiation therapy as a treatment for benign lymphoepithelial parotid cysts in patients infected with human immunodeficiency virus-1. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1992 ; 23 : 1045-1050

[20] Green TL, Eversole LR. Oral lymphomas in HIV-infected patients : association with Epstein-Barr virus DNA. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1989 ; 67 : 437-442

[21] Greenspan D, Schiodt M, Greenspan JS, Pindborg JJ. AIDS and the mouth : diagnosis and management of oral lesions. Copenhagen : Munksgaard, 1990 : 91-134

[22] Holecek MJ, Harwood AR. Radiotherapy of Kaposi's sarcoma. *Cancer* 1978 ; 41 : 1733-1738

[23] Huang RD, Pearlman S, Friedman WH, Loree T. Benign cystic vs solid lesions of the parotid gland in HIV patients. *Head Neck* 1991 ; 13 : 522-527

[24] Ioachim HL, Ryan JR. Salivary gland lymphadenopathy associated with AIDS. *Hum Pathol* 1988 ; 19 : 616-617

[25] Itescu S, Brancato LJ, Winchester R. A Sicca syndrome in HIV infection : association with HLA-DR55 and CDO lymphocytosis. *Lancet* 1989 ; 2 : 466-468

[26] Jones AC, Freedman PD, Phelan JA, Baughman RA, Kerpel SM. Cytomegalovirus infections of the oral cavity. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1993 ; 75 : 76-85

[27] Klein E, Schwartz RA, Laor Y. Treatment of Kaposi's sarcoma with vinblastine. *Cancer* 1980 ; 45 : 427-431

[28] Krause DH, Rehm SJ, Orlowski JP, Tubbs RR, Levine H. Upper airway obstruction due to tonsillar lymphadenopathy in human immunodeficiency virus infection. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1990 ; 116 : 738-740

[29] Krown SE. AIDS associated Kaposi 's sarcoma : pathogenesis, clinical course and treatment. *AIDS* 1988 ; 2 : 71-80

[30] Lee KC, Cheung SW. Evaluation of the neck mass in human deficiency virus-infected patients. *Otolaryngol Clin North Am* 1992 ; 25 : 1287-1303

[31] Leess FR, Kessler DJ, Mickel RA. Non-Hodgkin lymphoma of the head and neck in patients with AIDS. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1987 ; 113 : 1104-1106

[32] Linsrom CJ, Pincus RL, Leavitt EB. Otologic manifestations of HIV-related disease. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1993 ; 108 : 680-688

[33] Mellors JW, Kingsley LA, Rinaldo CR, Todd JA, Hoo BS, Kokka RP et al. Quantitation of HIV-1 RNA in plasma predicts outcome after seroconversion. *Ann Intern Med* 1995 ; 122 : 573-579

[34] Monfardini S, Vaccher E, Pizzocardo G, Stellini R, Sinicco A, Sabbatani S et al. Unusual malignant tumours in 49 patients with HIV infection. *AIDS* 1989 ; 3 : 449-452

[35] Morris MS, Pradad S. Otologic disease in the acquired immunodeficiency syndrome. *Ear Nose Throat J* 1990 ; 69 : 451-453

[36] Mykowski S, Strauss PL, Safai B. Lymphoma and other HIV-associated malignancies et al. *J Am Acad Dermatol* 1990 ; 22 : 1253-1260

[37] Payne SF, Lemp GF, Rutherford GW. Survival following diagnosis of Kaposi's sarcoma for AIDS patients in San Francisco. *J AIDS* 1990 ; 3 (suppl 1) : 14-17

[38] Perrin C, Vandenbos F, Galibert A, Dumon MC, Limouse L, Thyss A et al. Une sténose trachéale, mode de révélation exceptionnel du lymphome de Burkitt au cours du SIDA. *Presse Med* 1995 ; 24 : 958

[39] Raphaël M, Eclache V, Martin A, Feuillard J. Les lymphomes du SIDA. *Med/Sci* 1995 ; 5 : 713-721

[40] Redleaf MI, Bauer CA, Robinson RA. Fine needle detection of cytomegalovirus parotidis in a patient with acquired immunodeficiency syndrome. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1994 ; 120 : 414-416

[41] Reiss P, Haddering R, Schot LJ, Danner SA. Invasive external otitis caused by *Aspergillus fumigatus* in two patients with AIDS. *AIDS* 1991 ; 5 : 605-606

[42] Réseau National de Santé Publique. Surveillance du SIDA en France. *Bull Epidemiol Hebd* 1996 ; 10 : 45-52

[43] Révision de la définition du SIDA en France. *Bull Epidemiol Hebd* 1993 ; 11 : 47-48

[44] Ryan JR, Ioachim HL, Marmer J, Loubeau JM. Acquired imunodeficiency syndrome-related lymphadenopathies presenting in the salivary gland lymph nodes. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1985 ; 111 : 554-556

[45] Saiag P. Maladie de Kaposi : une origine virale qui se précise. *J Sida* 1995 ; 75 : 6-8

[46] Schiodt M, Dodd CL, Greespan D, Daniels TE, Chernoff D, Hollander H et al. Natural history of HIV-associated salivary gland disease. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1992 ; 74 : 326-331

[47] Sciuba JJ. Recognizing the oral manifestations of AIDS. *Oncology* 1992 ; 6 : 64-70

[48] Shaha AR, Dimaio T, Webber C, Thelmo W, Jaffe BM. Benign lymphoepithelial lesions of the parotid. *Am J Surg* 1993 ; 166 : 403-406

[49] Shapiro AL, Pincus RL. Fine-needle aspiration of diffuse cervical lymphadenopathy in patients with acquired immunodeficiency syndrome. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1991 ; 105 : 419-421

[50] Silverman S, Migliorati CA, Lozadanur F, Greenspan D, Conant MA. Oral findings in people with or at high risk for AIDS : a study of 375 homosexual males. *J Am Dent Assoc* 1986 ; 112 : 187-192

[51] Sperling NM, Lin PT. Parotid disease associated with human immunodeficiency virus infection. *Ear Nose Throat J* 1990 ; 69 : 475-477

[52] Tami TA. The management of sinusitis in patients infected with the human immunodeficiency virus. *Ear Nose Throat J* 1995 ; 74 : 360-363

[53] Tami TA, Wawrose SF. Diseases of the nose and paranasal sinus in the human immunodeficiency virus-infected population. *Otolaryngol Clin North Am* 1992 ; 25 : 1199-1210

[54] Terry JH, Loree TR, Thomas MD, Marti JR. Major salivary gland lymphoepithelial lesions of the acquired immunodeficiency syndrome. *Am J Surg* 1991 ; 162 : 324-329

[55] Ulrisch RC, Jaffe ES. Sjögren's syndrome-like illness associated with the acquired immunodeficiency syndrome-related complex. *Hum Pathol* 1987 ; 18 : 1063-1068

[56] Volpe F, Schwimmer A, Barr C. Oral manifestations of disseminated *Mycobacterium avium intra-cellulare* in a patient with AIDS. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1985 ; 60 : 567-570

[57] Wax TD, Layfield LJ, Zaleski S. Cytomegalovirus sialadenitis in patients with the acquired immunodeficiency syndrome : a potentiel diagnostic pitfall with fine needle aspiration cytology. *Diagn Pathol* 1994 ; 10 : 169-172

[58] Zeitlen S, Shaha A. Parotid manifestations of HIV infection. *J Surg Oncol* 1991 ; 47 : 230-232

[59] Ziegler JL, Becktead JA, Volberding PA. Non Hodgkin's lymphoma in 90 homosexual men : relation to generalized lymphadenopathy and the acquired immuno-deficiency syndrome. *N Engl J Med* 1984 ; 311 : 565-570

[60] Zurlo JJ, Feuerstein IM, Lebovics R, Lane HC. Sinusitis in HIV-1 infection. *Am J Med* 1992 ; 93 : 157-162